

CLASSIFICAÇÃO DE ESTADO FÍSICO ASA

American Society of Anesthesiologists — Avaliação e Estratificação do Risco Cirúrgico-Anestésico

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	__/__/__ às __:__

2. ESTRATIFICAÇÃO CLÍNICA PRÉ-OPERATÓRIA (SELECIONAR A CATEGORIA DO PACIENTE)

Classe	Definição Clínica e Exemplos Típicos	Recomendações e Cuidados de Enfermagem	Seleção
ASA I	Paciente Hígido: Normal, saudável, sem distúrbios orgânicos, fisiológicos ou psiquiátricos. Não fumante, consumo nulo/social mínimo de álcool.	Preparo cirúrgico padrão, confirmação de jejum pré-operatório e identificação segura.	☐
ASA II	Doença Sistêmica Leve a Moderada: Sem limitação funcional substancial. Ex: HAS bem controlada, DM sem complicações, tabagista ativo, gestação, obesidade IMC 30-39.	Checação de medicações de uso contínuo, monitorização glicêmica e pressórica.	☐
ASA III	Doença Sistêmica Grave: Limitação funcional substancial, mas não incapacitante. Ex: DPOC, DM descompensado, HAS estágio 2, IAM prévio (>3m), obesidade mórbida (IMC ≥40).	Monitorização multiparamétrica contínua, reserva de hemoderivados e vigilância estrita.	☐
ASA IV	Doença Grave com Ameaça Constante à Vida: Incapacitante. Ex: IAM recente (<3m), angina instável, ICC descompensada, sepse, disfunção renal em diálise irregular.	Acesso venoso calibroso/invasivo, drogas vasoativas preparadas e reserva de leito de UTI.	☐
ASA V	Paciente Moribundo: Não se espera sobrevivência sem o procedimento cirúrgico nas próximas 24h. Ex: rotura de aneurisma aórtico, politrauma catastrófico.	Assistência intensiva contínua, infusão rápida de hemocomponentes e suporte ventilatório total.	☐
ASA VI	Morte Encefálica Declarada: Paciente com suporte hemodinâmico para retirada de órgãos destinados a transplante.	Manutenção rigorosa de perfusão e oxigenação conforme protocolo da CIHDOTT/CNCDO.	☐

Sufixo de Emergência (E): Acrescenta-se a letra 'E' quando a intervenção é emergencial, sem tempo de estabilização prévia: ☐ Procedimento Cirúrgico de Emergência (E)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ANESTÉSICO-CIRÚRGICO ATRIBUÍDA: [ASA]

3. DIRETRIZES DE SEGURANÇA CIRÚRGICA E PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL

ASA I e II (BAIXO A MODERADO RISCO)	ASA III (ALTO RISCO CIRÚRGICO)	ASA IV, V e VI (RISCO CRÍTICO / UTI)
Recuperação pós-anestésica habitual na SRPA; transferência planejada para leito de enfermaria/quarto após atingir critérios de alta.	Vigilância hemodinâmica avançada na SRPA; avaliar necessidade de suporte intermediário ou monitorização invasiva contínua.	Transferência direta do centro cirúrgico para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com ventilação mecânica e drogas vasoativas.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data